

Praca z *głosami*

Nie eliminacja, lecz zmiana relacji. 5–15% populacji ogólnej słyszy głosy — nie wszyscy chorują. Można nauczyć się z nimi żyć.

CZAS: 20 min · do powtarzania 1 głos na raz · po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Romme & Escher (1993, 2000); Chadwick (2006, PICS); Birchwood (2004)

JAK UŻYWAĆ

Wypełnij **analizę głosu** (sekcja 1) i **plan reakcji** (sekcje 2–3) dla *jednego konkretnego głosu*, który najczęściej Cię niepokoi. Skala dystresu w sekcji 4 — zaznacz raz teraz, raz po tygodniu pracy z planem. Plan bezpieczeństwa (sekcja 5) — wypełnij *zanim* będzie potrzebny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczne podejście („to halucynacja, nie istnieje”) rzadko pomaga — pacjent czuje się niezrozumiany, opór. Romme & Escher (1993) — twórcy ruchu *Hearing Voices* („Sieć Słyszących Głosy”) — pokazali, że **70–80%** osób uczy się z głosami żyć funkcjonalnie. Chadwick (2006, model PICS — ang. *Power, Identity, Content, Significance*): kluczem jest *relacja* z głosem, nie jego treść. Zmiana relacji → spadek dystresu, nawet gdy głosy się utrzymują.

01 Analiza głosu — cztery wymiary

Model PICS (Chadwick, 2006) — ang. *Power, Identity, Content, Significance* — opisuje cztery wymiary, w których można zrozumieć i osłabić głos. Wybierz **jeden głos**, który Cię niepokoi najbardziej, i opisz go w czterech polach.

P — WŁADZA

jak silny jest 0–10, czy muszę słuchać, co się stanie gdy odmówię

I — TOŻSAMOŚĆ

kto to mówi, czym głosem przemawia, czy go znam

C — TREŚĆ

co dokładnie mówi, krytykuje, komentuje, nakazuje

S — ZNACZENIE

jak rozumiem, skąd ten głos się bierze, kiedy się nasila

02 Trzy grupy strategii

POZNAWCZE

zmiana relacji

„Słyszę głos, który mówi X. To jest **głos**, nie fakt.” Nazwij głos, opisz go z dystansem. Defuzja (terapia akceptacji i zaangażowania).

BEHAWIORALNE

odwrócenie uwagi

Słuchawki z muzyką, rozmowa, ćwiczenie 5–4–3–2–1 (5 rzeczy, które widzisz, 4 słyszysz, 3 czujesz, 2 wąchasz, 1 smakujesz). Zakotwiczenie w zmysłach.

ASERTYWNE

stawianie granic

Odpowiedz głosowi (w myśli lub na głos): „Nie zgadzam się. To *Twoja opinia, nie fakt.*” Ustal czas na głos (15 min dziennie), poza tym — koegzystencja.

03 Mój plan reakcji

CO NAJCZĘŚCIEJ NASILA GŁOS

— stres, samotność, brak snu, substancje

CO NAJCZĘŚCIEJ OSŁABIA GŁOS

— aktywność, rozmowa, sen, lek

04 Dystres związany z głosem — przed i po

Zaznacz raz dziś, raz po tygodniu pracy z planem. Mierzysz dystres — czyli ile cierpienia ten głos sprawia. Nie mierzysz czy *słyszysz* głos (to się może nie zmienić). Mierzysz *ile Cię to boli*.

Dystres
dziś

brak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nieznośny

Dystres
po
tygodniu

brak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nieznośny

05 Plan bezpieczeństwa — gdy głos nakazuje krzywdę

Jeśli głos nakazuje Ci skrzywdzić siebie lub kogoś — nie wykonuj polecenia. Eksperymenty z głosami (sekcja Chadwick: *command auditory hallucinations*) pokazują, że **nie wykonanie** nakazu prawie nigdy nie prowadzi do zapowiadanej kary. Głos nie ma realnej władzy. Zadzwoń do kogoś z poniższej listy *zanim* będziesz musiał/-a.

MÓJ TERAPEUTA / PSYCHIATRA

— imię, telefon

BLISKA OSOBA DO TELEFONU

— imię, telefon

Telefon zaufania: 116 123 (Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, 24/7) ·
Pogotowie: 112 · **SOR psychiatryczny** · Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Klucz: głosy nie zawsze znikają — ale *relacja* z nimi zmienia się prawie zawsze. Birchwood i in. (2004): siła odczuwana głosu i poczucie podporządkowania spadają, gdy pacjent **testuje władzę** głosu (nie wykonuje poleceń, odpowiada asertywnie). Chadwick (2006): głos jest często echem wczesnych doświadczeń (krytyczny rodzic, prześladowca) — zrozumienie tego nie usuwa głosu, ale *oddziela* go od poczucia własnej wartości. Praca z głosami **uzupełnia**, nie zastępuje farmakoterapii i CBTp.